PELVIS · PE-03

# Endométriose · IRM

**ESUR 2025 · dPEI**
indications, protocole, compte rendu par compartiments

## INDICATIONS DE L'IRM (ESUR 2025)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Échographie endovaginale **non concluante** | Échographie **négative** chez une patiente symptomatique | **Avant une chirurgie** ou un geste interventionnel | Après chirurgie si **symptômes persistants** |

## PRÉPARATION ET PROTOCOLE

### Préparation

- Jeûne de quelques heures
- **Antispasmodique** (sauf contre-indication)
- Vessie **modérément remplie**
- Préparation digestive (lavement rectal ou régime)
- Opacification vaginale et rectale par gel : optionnelle

### Séquences

- **T2 multiplanaire** (sagittal, axial, oblique), sans saturation de graisse
- **T1 et T1 avec saturation de graisse** : foyers hémorragiques, endométriomes, endométriose superficielle
- Couverture des **reins** (hydronéphrose)
- Injection et diffusion : non systématiques (masse atypique, adénomyose, transformation)

## LECTURE PAR COMPARTIMENTS · CLASSIFICATION DPEI

### 9 compartiments + 1

Deux lignes horizontales (entre vessie et utérus, entre utérus et rectosigmoïde) et deux lignes verticales (fascias viscéraux) divisent le pelvis en compartiments **antérieur, central (médio-central), postérieur**, chacun avec ses parties **latérales droite et gauche**, plus un compartiment **extra-pelvien**.

### Score de sévérité

| ATTEINTE | SÉVÉRITÉ |
|---|---|
| ≤ 2 compartiments | Légère |
| 3–4 compartiments | Modérée |
| ≥ 5 compartiments | Sévère |

1 point par compartiment atteint ; point supplémentaire si l'atteinte latérale dépasse le fascia pariétal. Corrélé à la durée opératoire, à la durée d'hospitalisation et aux troubles mictionnels.

### Compartiments

- **Antérieur** : cul-de-sac vésico-utérin, vessie, uretère distal
- **Central** : utérus, col, vagin, torus, ligaments utéro-sacrés proximaux
- **Postérieur** : charnière recto-sigmoïdienne, rectum
- **Latéraux** : paramètres, ligaments utéro-sacrés distaux, uretères, nerfs

## LEXIQUE

| LÉSION | ASPECT IRM |
|---|---|
| **Endométriose profonde** | Nodule ou épaississement **hypo-intense T2** (fibrose), parfois foyers T1 hyperintenses (sang) ou T2 hyperintenses (glandes) ; rétraction |
| **Endométriose superficielle** | Foyers **hyperintenses en T1 avec saturation de graisse** à la surface péritonéale |
| **Endométriome** | Hyperintense T1, **« shading » en T2** (perte de signal), parfois tache sombre en T2 ; souvent bilatéral |
| **Atteinte digestive** | Signe du « champignon » ; préciser la distance à la marge anale, la longueur, la profondeur pariétale, la circonférence |
| **Adénomyose** | Épaississement de la zone jonctionnelle (≥ 12 mm), kystes sous-endométriaux T2 hyperintenses ; formes focales |
| **Oblitération du cul-de-sac** | Adhérences, angulation, attraction des anses et des ovaires (« kissing ovaries ») |

## COMPTE RENDU STRUCTURÉ

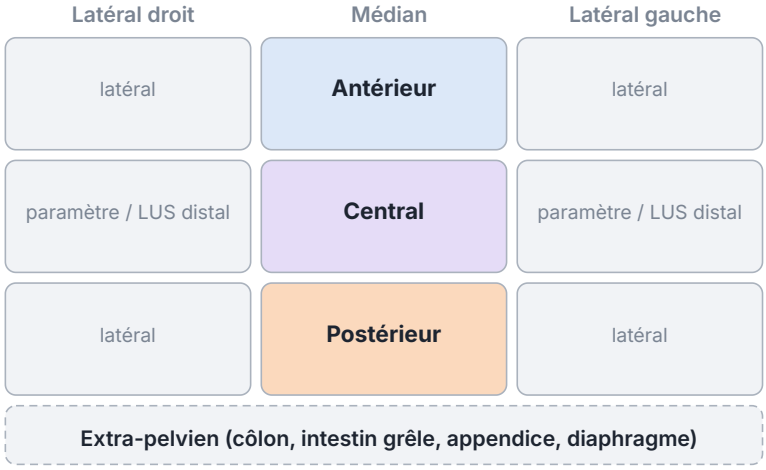
| | | | |
|---|---|---|---|
| **Par compartiment** localisation, taille, rapports (uretère, nerfs, rectum) | **Digestif** hauteur, longueur, profondeur, nombre de lésions | **Urinaire** vessie, uretères, hydronéphrose | **Synthèse** score dPEI, endométriomes, adénomyose |

# Endométriose · IRM (suite)



## ATLAS VISUEL

### Compartiments du pelvis (dPEI) · vue schématique




**Antérieur**
vessie, cul-de-sac vésico-utérin, uretère distal

**Central**
utérus, col, vagin, torus, LUS proximaux

**Postérieur**
rectum, charnière recto-sigmoïdienne

Sévérité : ≤ 2 compartiments légère · 3–4 modérée · ≥ 5 sévère · LUS = ligaments utéro-sacrés · Schémas simplifiés, non à l'échelle

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**Endométriose**
Radiopaedia · localisations
radiopaedia.org/articles/endometriosis?lang=us

**Protocole IRM endométriose**
Radiopaedia · séquences
radiopaedia.org/articles/pelvic-protocol-for-end

**Signe du champignon (cas)**
Radiopaedia · atteinte recto-sigmoïdienne
radiopaedia.org/cases/rectosigmoid-endometriosis

**Adénomyose**
Radiopaedia · zone jonctionnelle
radiopaedia.org/articles/adenomyosis

**Classification dPEI (Hum Reprod 2020)**
Article original
academic.oup.com/humrep/article/35/7/1589/586700

**Sources :** ESUR consensus 2025 – indications, reporting, classifications – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40425757/ · ESUR consensus 2025 – protocol, lexicon, compartments – link.springer.com/article/10.1007/s00330-025-11611-3 · dPEI classification (Hum Reprod 2020) – academic.oup.com/humrep/article/35/7/1589/5867009